

CAPÍTULO 14.25

Arteritis de Takayasu

PERFIL EUNACOM 1.01.1.016
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Arteritis de Takayasu** es una vasculitis crónica que afecta predominantemente a la **aorta y sus ramas principales**. Se caracteriza por una inflamación granulomatosa que conduce a la estenosis, oclusión o dilatación aneurismática de los vasos afectados. Es conocida clásicamente como la **"enfermedad sin pulso"**.

Epidemiología y Clínica Inicial

Esta patología tiene una presentación demográfica muy característica que suele ser clave para las preguntas de examen: - **Perfil típico:** Mujer joven (generalmente menor de 40-50 años). - **Fase Sistémica (Pre-oclusiva):** A menudo debuta con síntomas inespecíficos que dificultan el diagnóstico precoz: - Astenia (cansancio). - Fiebre de origen desconocido. - Cefalea. - Artralgias.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante una **mujer joven** con síntomas constitucionales (fiebre, baja de peso) y **elevación marcada de parámetros inflamatorios** (VHS/PCR) sin una causa infecciosa clara, siempre se debe considerar una vasculitis de grandes vasos como Takayasu.

Manifestaciones Clínicas y Complicaciones

Una vez que la inflamación progresa hacia la etapa oclusiva, aparecen los signos de isquemia por la estrechez de las arterias:

- **Ausencia de pulsos:** Gran caída o ausencia del pulso radial (frecuentemente asimétrico).
- **Claudicación de extremidades:** Dolor muscular al usar los brazos (afectación de la arteria subclavia).
- **Soplos vasculares:** Presencia de soplos a nivel cervical (carótidas), supraclavicular o abdominal.
- **Compromiso Cerebrovascular:** Debido a la estenosis de carótidas o arterias vertebrales, puede presentarse como:
 - Accidentes Vasculares Encefálicos (AVE).
 - Accidentes Isquémicos Transitorios (AIT).
- **Hipertensión Arterial (HTA):** Generalmente de origen **renovascular**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la HTA en Takayasu: La hipertensión se produce por dos mecanismos: la rigidez de la aorta y, más frecuentemente, por la estenosis de las arterias renales. Esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona al llegar menos flujo al riñón, generando una **Hipertensión arterial secundaria**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si encuentras a un paciente inconsciente y sin pulso, el diagnóstico es **Paro Cardiorrespiratorio**, no Takayasu. La Arteritis de Takayasu se sospecha en un paciente que se ve "aparentemente bien" o estable, pero en quien no se palpan los pulsos periféricos de forma simétrica.

Diagnóstico

El diagnóstico de la Arteritis de Takayasu es fundamentalmente clínico apoyado por imágenes, ya que no posee marcadores serológicos patognomónicos.

TABLA 14.25.1: PARÁMETRO VS HALLAZGO EN TAKAYASU

PARÁMETRO	HALLAZGO EN TAKAYASU
Laboratorio General	Elevación de VHS y PCR (indican actividad inflamatoria).
Anticuerpos	ANCA Negativo. No hay anticuerpos específicos.
Imagen de elección	Angio-Resonancia (Angio-RM) o Angio-TAC.
Gold Standard	Arteriografía convencional (muestra estenosis, oclusiones y dilataciones).

Manejo y Tratamiento

El objetivo del tratamiento es detener la progresión de la inflamación y restaurar el flujo sanguíneo en vasos críticos.

- **Tratamiento Médico:**
 - **Corticoides sistémicos:** Son el pilar del tratamiento inicial para bajar la inflamación y evitar que la obstrucción progrese.
 - Inmunosupresores (ahorradores de corticoides) en casos refractarios.
- **Tratamiento Quirúrgico / Endovascular:**
 - Se reserva para cuando ya existe una obstrucción establecida que genera síntomas graves (isquemia de extremidades, estenosis renal significativa o compromiso coronario).
 - Opciones: Angioplastia, instalación de stents o cirugía de bypass (endarterectomía).

EUNACOM CRITERIOS

Los corticoides ayudan a **evitar la progresión** de la enfermedad, pero raramente reversion una obstrucción fibrótica ya establecida. Por ello, el manejo suele ser multidisciplinario entre reumatología y cirugía vascular.

Resumen para el EUNACOM

- **Paciente:** Mujer joven. - **Clave clínica:** Diferencia de presión entre brazos o ausencia de pulsos radiales + soplos. - **Laboratorio:** VHS muy alta, ANCA negativo. - **Imagen:** Angio-RM mostrando compromiso de la aorta. - **Tratamiento:** Corticoides.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años con astenia, cefalea y ausencia de pulso radial bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Arteritis de Takayasu. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vasculitis de la aorta y sus ramas; típica de mujer joven
- Signo cardinal: ausencia o gran caída del pulso radial ('enfermedad sin pulso')
- Complicaciones: ACV/AIT, claudicación de extremidades superiores, hipertensión renovascular
- ANCA negativa, sin anticuerpo específico; PCR y VHS pueden estar elevadas
- Diagnóstico: angioimagen (angiorresonancia o angiografía) que muestre obstrucción de aorta y ramas
- Tratamiento: corticoides orales (detener avance) + cirugía vascular (desobstruir arterias)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTERITIS DE TAKAYASU)**PREGUNTA 1**

Mujer de 28 años con astenia, cefalea y ausencia de pulso radial bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Arteritis de células gigantes
- B)** Arteritis de Takayasu
- C)** Poliarteritis nodosa
- D)** Enfermedad de Kawasaki
- E)** Lupus eritematoso sistémico

PREGUNTA 2

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico de arteritis de Takayasu?

- A)** Biopsia de arteria temporal
- B)** Ecocardiograma
- C)** Angiorresonancia o angiografía
- D)** ANCA
- E)** Densitometría ósea

PREGUNTA 3

¿Por qué se requiere cirugía vascular además de corticoides en la arteritis de Takayasu?

- A)** Los corticoides no tienen efecto
- B)** Los corticoides evitan progresión pero no revierten la obstrucción establecida
- C)** La cirugía reemplaza a los corticoides
- D)** Solo se opera si hay hipertensión pulmonar
- E)** La cirugía es siempre de primera línea

RESUMEN: ARTERITIS DE TAKAYASU

La arteritis de Takayasu es una vasculitis de la aorta y sus ramas que se presenta habitualmente en mujeres jóvenes. La clínica inicial es inespecífica (astenia, fiebre, cefalea), pero el signo más importante es la gran caída o ausencia del pulso radial, de ahí su nombre de 'enfermedad sin pulso'. Como complicaciones puede generar ACV y AIT (por afectación de carótidas), claudicación de extremidades superiores (por afectación de subclavias), soplos cervicales o torácicos, e hipertensión renovascular. No tiene ningún marcador específico; a lo más se eleva la PCR y VHS. Es ANCA negativa y no tiene anticuerpo asociado. Las vasculitis ANCA negativas son generalmente menos agresivas que las ANCA positivas, aunque puede debutar con un ACV. El diagnóstico se hace con angioimagen (angiorresonancia o angiografía) que muestra la obstrucción de la aorta y sus grandes ramas. El tratamiento es con corticoides orales para detener el avance, más cirugía vascular para destapar las arterias ya obstruidas.